



unex centro
universitário
de excelência

Propedêutica Médica II

Exame Físico
Impressão Geral

Exame Físico

Terminada a anamnese, inicia-se o exame físico; contudo o examinador deve continuar suas indagações, complementando pontos não muito bem esclarecidos durante a anamnese. O contrário também ocorre, ou seja, começa-se o exame físico tão logo se encontra com o paciente, observando-o cuidadosamente. Em outras palavras: não pode haver uma rígida separação entre a anamnese e o exame físico.



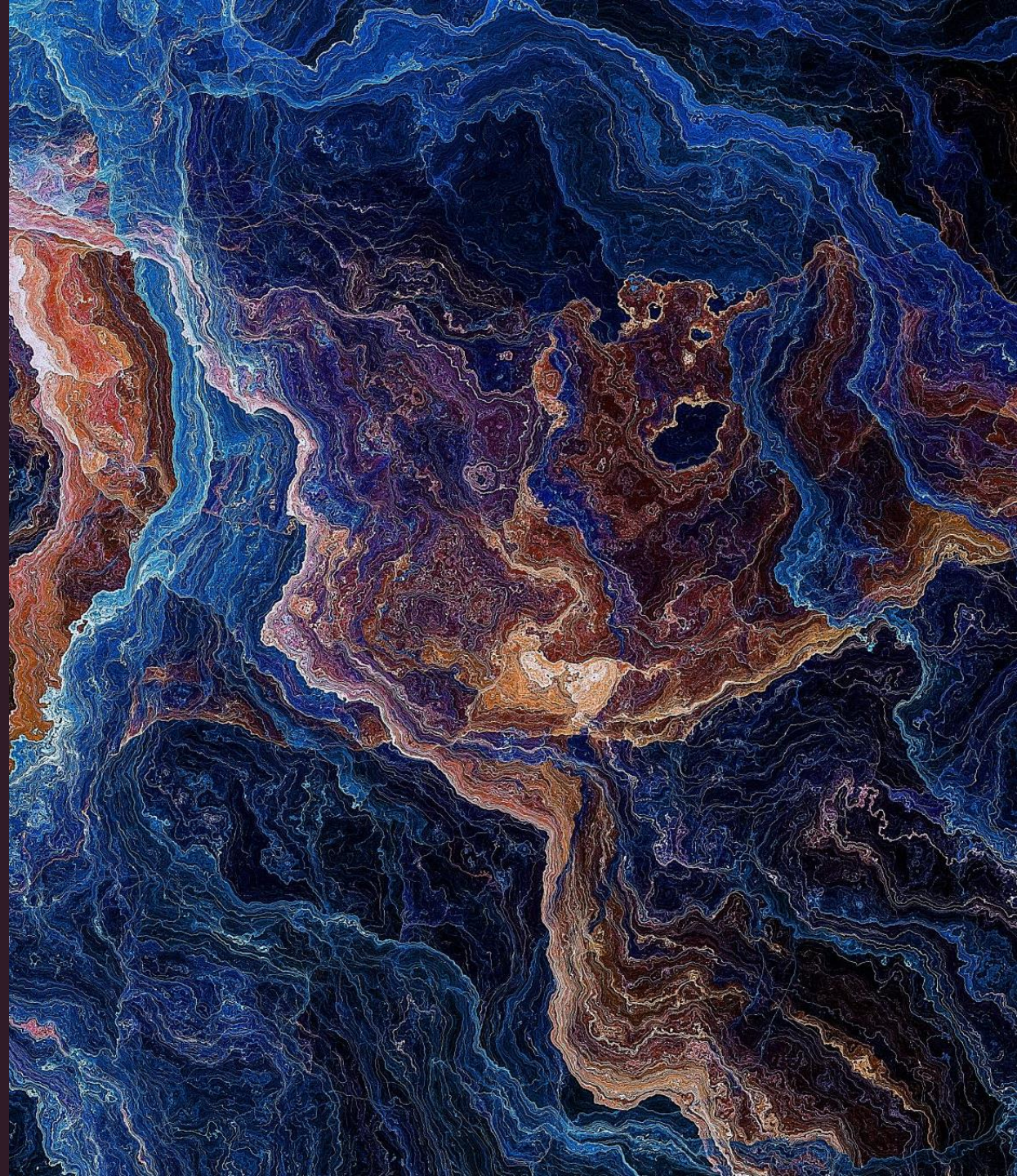
O exame físico pode ser dividido em duas etapas: a primeira constitui o que se costuma designar **exame físico geral, somatoscopia ou ectoscopia**, por meio do qual são obtidos dados gerais, independentemente dos vários sistemas orgânicos ou segmentos corporais, o que possibilita uma visão do paciente como um todo; a segunda etapa corresponde ao exame dos diferentes sistemas ou segmentos corporais, com metodologia própria

Exame Físico Geral

1. Avaliação do Estado Geral;
2. Avaliação do Nível de Consciência;
3. Fala e linguagem;
4. Fácies;
5. Atitude e decúbito preferido no leito;
6. Biotipo ou tipo morfológico.

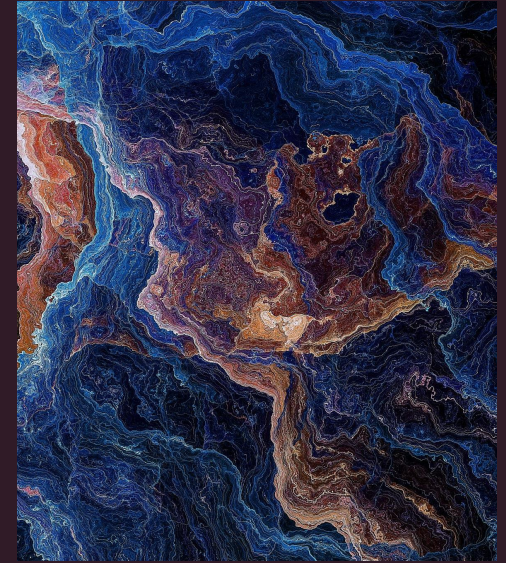


Objetivos da aula de hoje!



Exame Físico Geral

7. Altura e outras medidas antropométricas;
8. Avaliação do estado nutricional;
9. Desenvolvimento físico;
10. Pele, fâneros
11. Tecido celular subcutâneo e panículo adiposo;
12. Mucosas;
13. Avaliação do Estado de Hidratação;
14. Gânglios.



Aulas Subsequentes

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL

É uma avaliação subjetiva com base no conjunto de dados exibidos pelo paciente e interpretados de acordo com a experiência de cada um.

► Bom
estado geral

► Regular
estado geral

► Ruim
estado geral

AVALIAÇÃO DO ESTADO GERAL

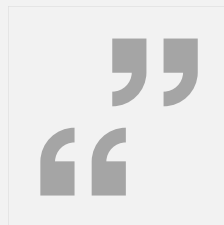
Serve ainda de alerta para o médico nos casos com escassos sinais ou sintomas indicativos de uma determinada enfermidade, obrigando-o a aprofundar sua investigação diagnóstica na busca de uma afecção que justifique a deterioração do estado geral.

Situação inversa também pode ocorrer, ou seja, a manutenção de um estado geral bom, na presença de uma doença sabidamente grave. Isso indica uma boa capacidade de reação do organismo que tem, inclusive, valor prognóstico.

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA



A avaliação do nível de consciência e do estado mental implica dois aspectos da mesma questão: a avaliação neurológica e a psiquiátrica.



A percepção consciente do mundo exterior e de si mesmo caracteriza o estado de vigília, que é resultante da atividade de diversas áreas cerebrais coordenadas pelo sistema reticular ativador ascendente.

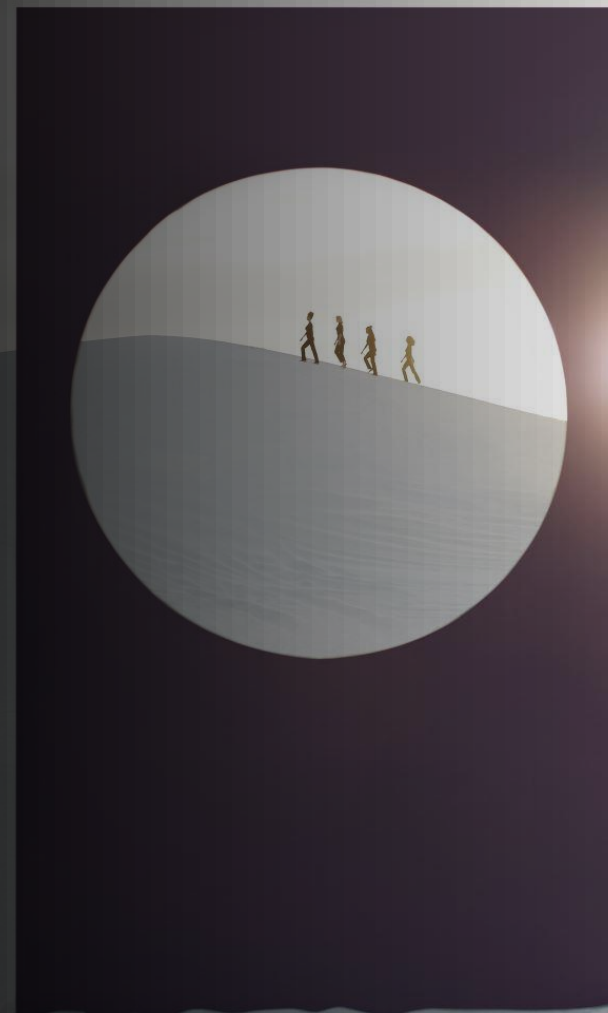


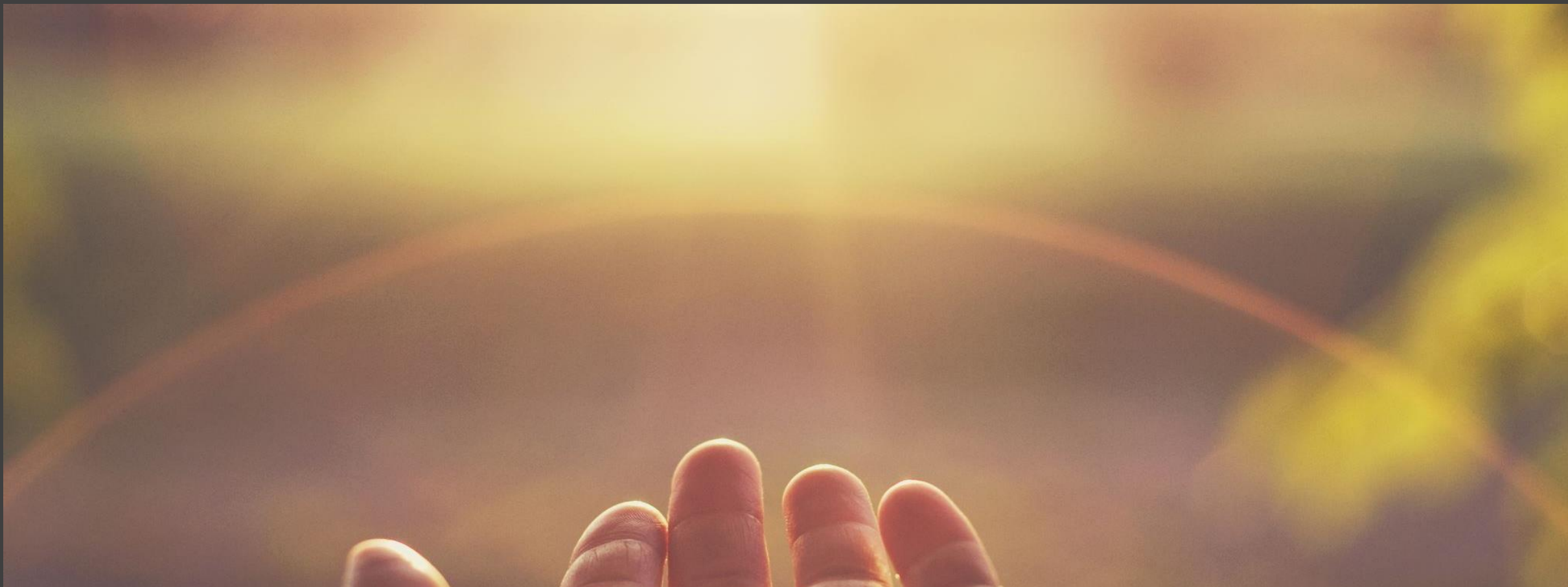
Entre o estado de vigília ou plena consciência e o estado comatoso, no qual o paciente perde completamente a capacidade de identificar seu mundo interior e os acontecimentos do meio que o circunda, é possível distinguir diversas fases intermediárias em uma graduação cujo principal indicador é o **nível de consciência**.

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

LÚCIDO E ORIENTADO EM TEMPO E ESPAÇO

- ✓ Obnubilação;
- ✓ Sonolência;
- ✓ Confusão mental;
- ✓ Torpor ou estupor;
- ✓ Coma.





AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

Quando a consciência é comprometida de modo pouco intenso, mas seu estado de alerta é moderadamente comprometido, chama-se ***obnubilação***.

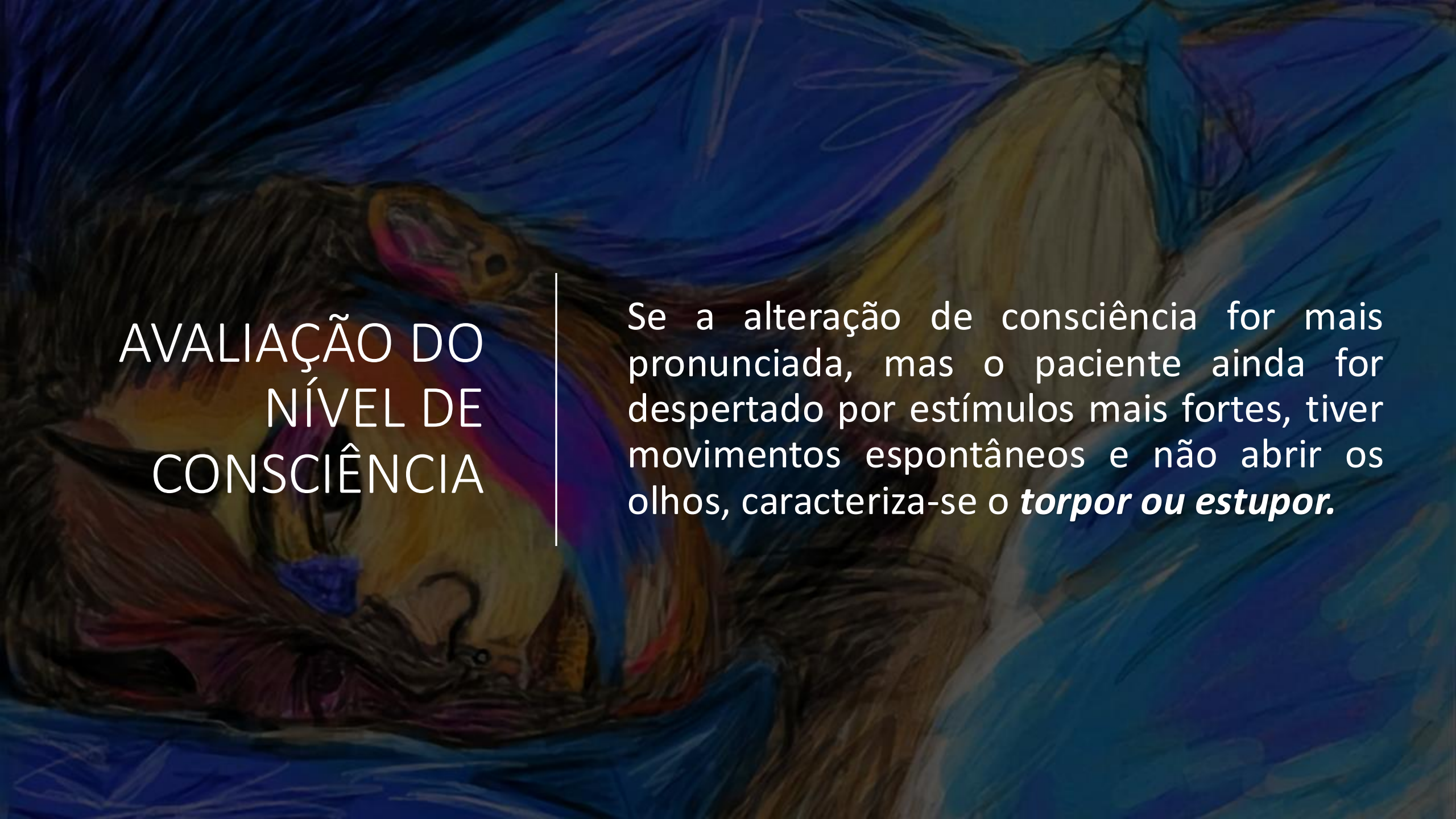
AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

Na ***sonolência***, o paciente é facilmente despertado, responde mais ou menos apropriadamente e volta logo a dormir.



AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

A ***confusão mental*** configura-se por perda de atenção, o pensamento não é claro, as respostas são lentas e não há percepção normal do ponto de vista temporoespacial, podendo surgir alucinações, ilusão e agitação.



AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

Se a alteração de consciência for mais pronunciada, mas o paciente ainda for despertado por estímulos mais fortes, tiver movimentos espontâneos e não abrir os olhos, caracteriza-se o ***torpor ou estupor***.

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

Se não há despertar com estimulação forte, e o paciente está sem movimentos espontâneos, caracteriza-se o ***estado de coma***.

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA

TABLE 6-2 GLASGOW COMA SCALE (GCS)

ORIGINAL SCALE	REVISED SCALE	SCORE
Eye Opening (E) Spontaneous To speech To pain None	Eye Opening (E) Spontaneous To sound To pressure None Non-testable	4 3 2 1 NT
Verbal Response (V) Oriented Confused conversation Inappropriate words Incomprehensible sounds None	Verbal Response (V) Oriented Confused Words Sounds None Non-testable	5 4 3 2 1 NT
Best Motor Response (M) Obeys commands Localizes pain Flexion withdrawal to pain Abnormal flexion (decorticate) Extension (decerebrate) None (flaccid)	Best Motor Response (M) Obeys commands Localizing Normal flexion Abnormal flexion Extension None Non-testable	6 5 4 3 2 1 NT

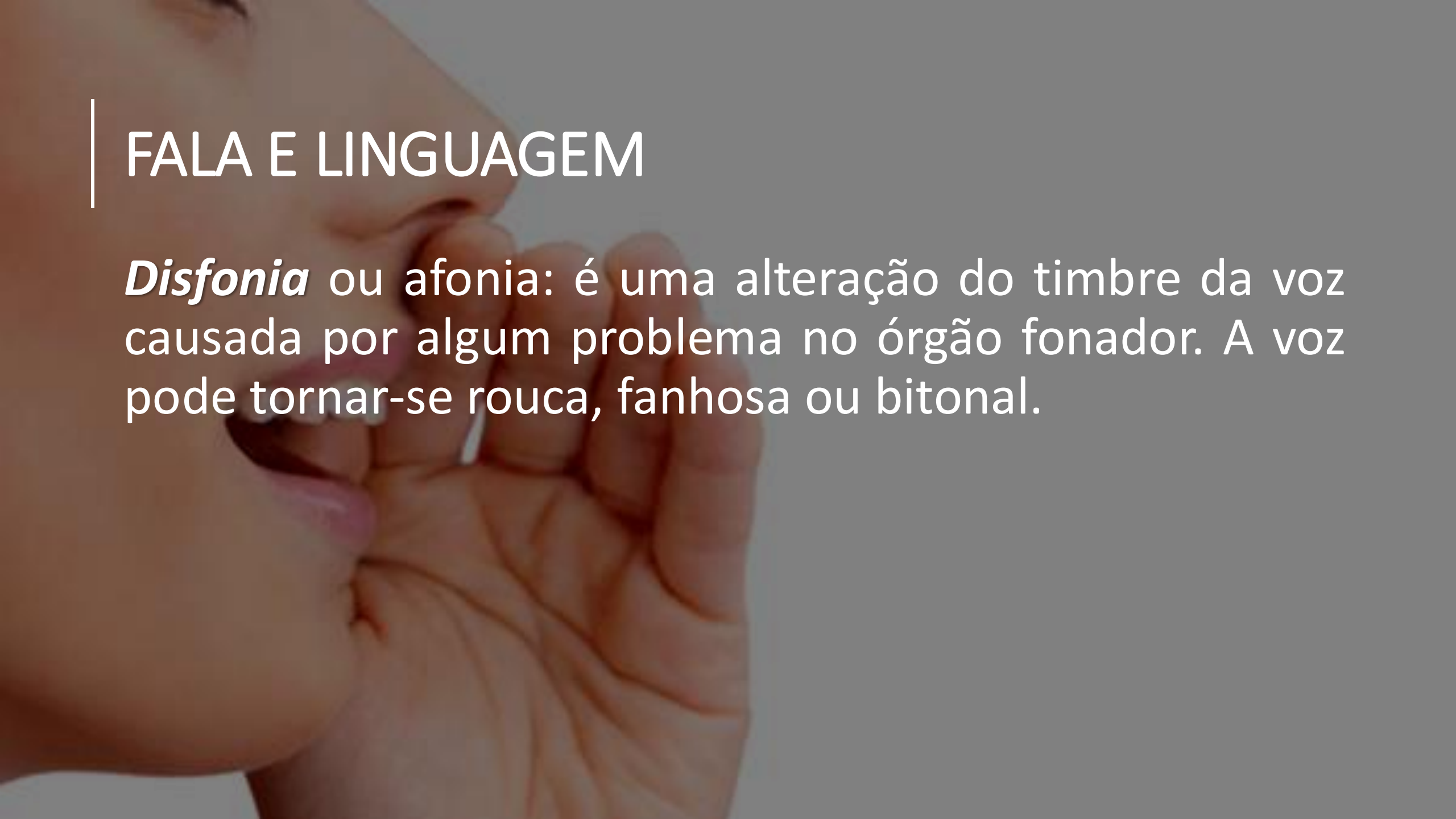
FALA E LINGUAGEM

- Durante a entrevista, o examinador deve prestar atenção à linguagem do paciente, particularmente na linguagem falada (fala);
- A fala depende de mecanismos bastante complexos que compreendem o órgão fonador (laringe), os músculos da fonação e a elaboração cerebral.



FALA E LINGUAGEM

- Disfonia;
- Dislalia;
- Disartria;
- Disfasia.



FALA E LINGUAGEM

Disfonia ou afonia: é uma alteração do timbre da voz causada por algum problema no órgão fonador. A voz pode tornar-se rouca, fanhosa ou bitonal.

FALA E LINGUAGEM



Dislalia é o termo que se usa para designar alterações menores da fala, comuns em crianças, como a troca de letras (“tasa” por “casa”).

Uma forma especial é a ***disritmolalia***, que compreende distúrbios no ritmo da fala, tais como a gagueira e a taquilalia.

FALA E LINGUAGEM

Disartria: decorre de alterações nos músculos da fonação, incoordenação cerebral (voz arrastada, escandida), hipertonia no parkinsonismo (voz baixa, monótona e lenta) ou perda do controle piramidal (paralisia pseudobulbar).



FALA E LINGUAGEM

Disfasia aparece com completa normalidade do órgão fonador e dos músculos da fonação e depende de uma perturbação na elaboração cortical da fala. Há diversos graus de disfasia, desde alterações mínimas até perda total da fala.

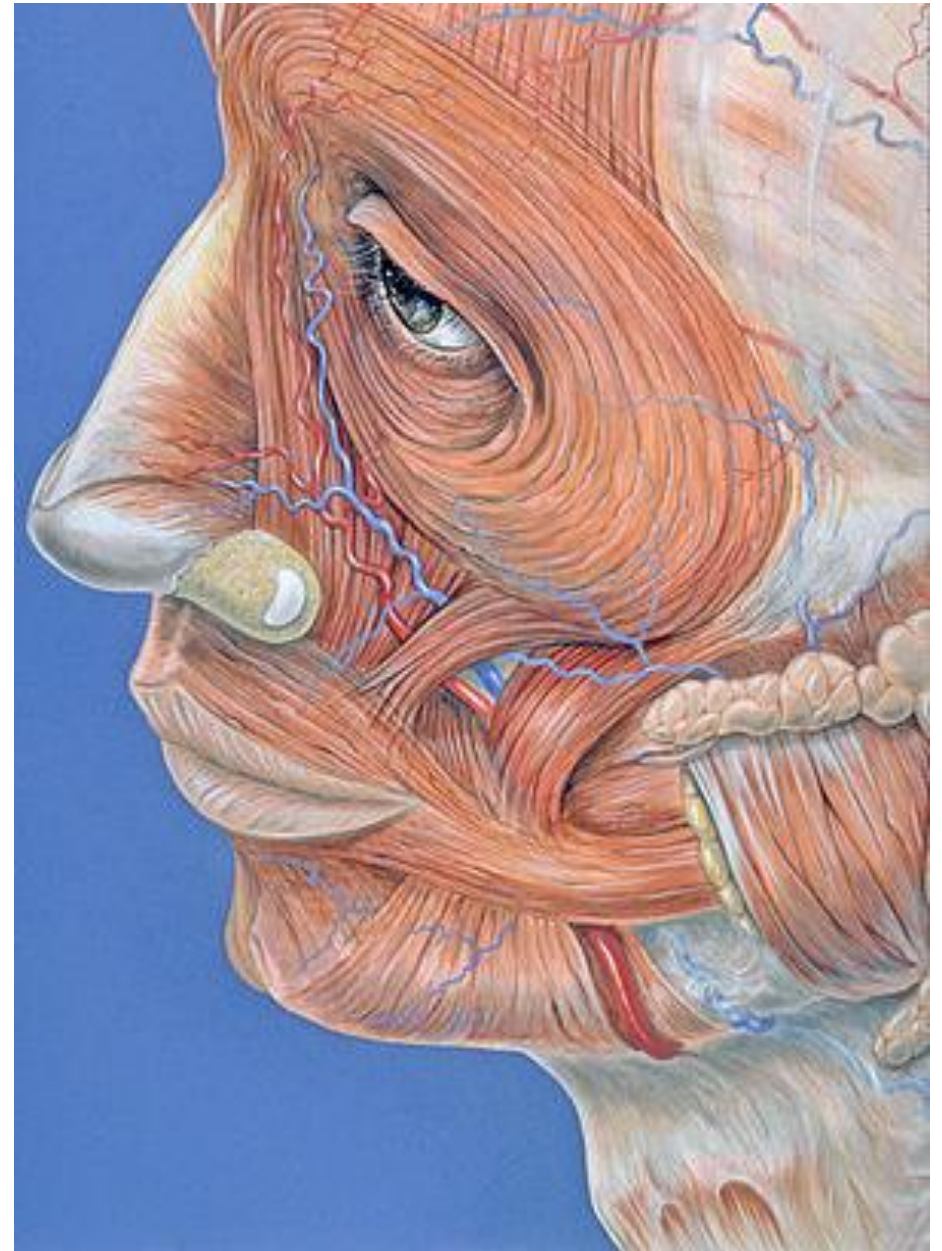
A disfasia pode ser de recepção ou sensorial (o paciente não entende o que se diz a ele), ou de expressão ou motora (o paciente entende, mas não consegue se expressar), ou ainda do tipo misto, que é, aliás, o mais frequente. A disfasia traduz lesão do hemisfério dominante: o esquerdo no destro, e vice-versa, mas não chega a ter valor localizatório muito preciso.



FÁCIES

Conjunto de dados exibidos na face do paciente. É a resultante dos traços anatômicos mais a expressão fisionômica.

Não apenas os elementos estáticos, mas, e principalmente, a expressão do olhar, os movimentos das asas do nariz e a posição da boca.





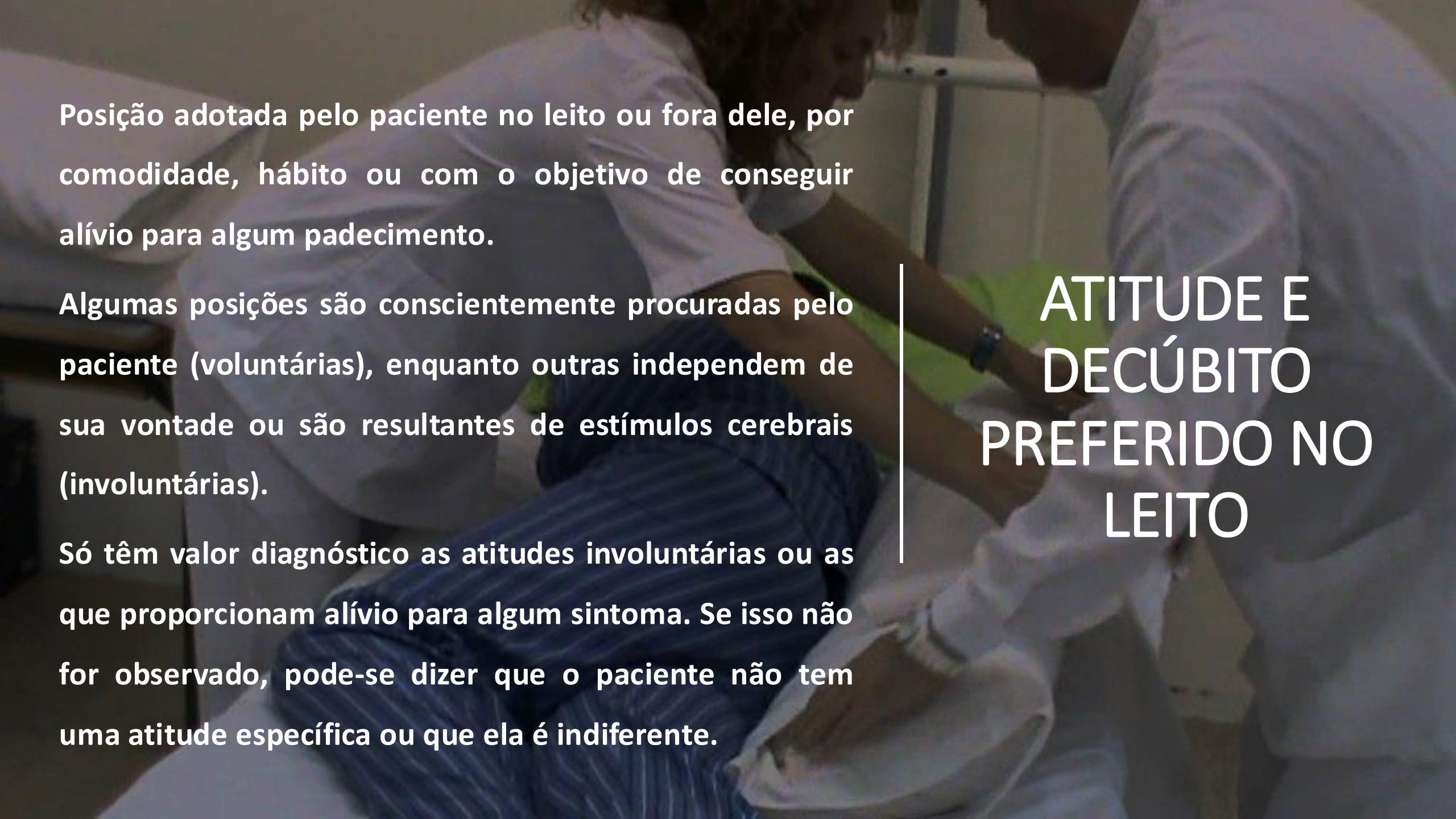
TIPOS DE FÁCIES

- Facies normal ou atípica;
- Facies hipocrática;
- Facies renal;
- Facies leonina;
- Facies adenoidiana;
- Facies parkinsoniana;
- Facies basedowiana;
- Facies mixedematosa;
- Facies acromegálica;
- Facies cushingoide;

TIPOS DE FÁCIAS

- Fácies mongoloide;
- Fácies de depressão;
- Fácies pseudobulbar;
- Fácies de paralisia facial periférica;
- Fácies miastênica;
- Fácies etílica;
- Fácies esclerodérmica.





Posição adotada pelo paciente no leito ou fora dele, por comodidade, hábito ou com o objetivo de conseguir alívio para algum padecimento.

Algumas posições são conscientemente procuradas pelo paciente (voluntárias), enquanto outras independem de sua vontade ou são resultantes de estímulos cerebrais (involuntárias).

Só têm valor diagnóstico as atitudes involuntárias ou as que proporcionam alívio para algum sintoma. Se isso não for observado, pode-se dizer que o paciente não tem uma atitude específica ou que ela é indiferente.

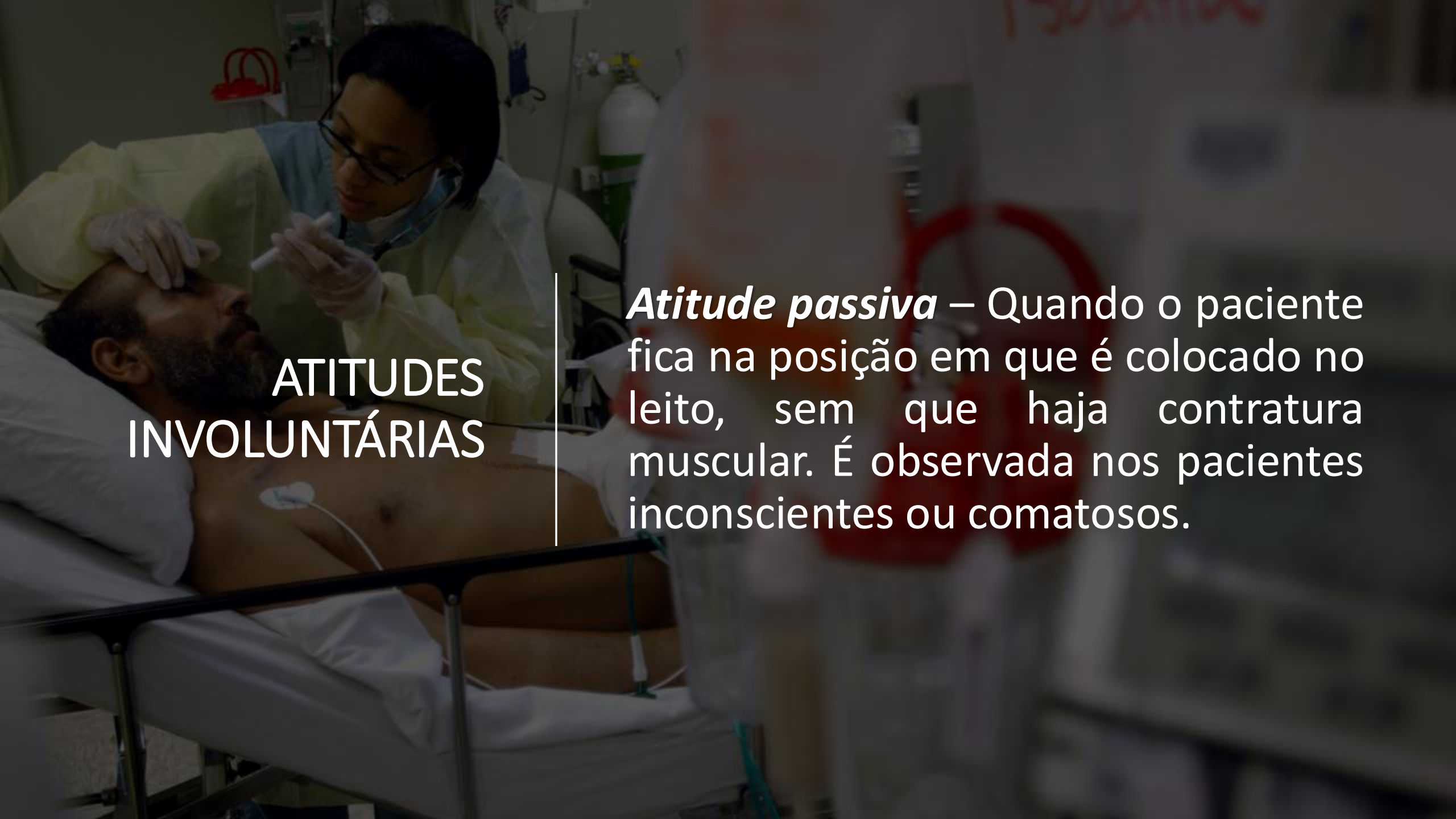
ATITUDE E DECÚBITO PREFERIDO NO LEITO

ATITUDES VOLUNTÁRIAS

- Atitude ortopneica (ortopneia);
- Atitude genupeitoral (ou de “prece maometana”);
- Atitude de cócoras (squatting);
- Atitude parkinsoniana;
- Atitude em decúbito:
 - Decúbito lateral (direito e esquerdo);
 - Decúbito dorsal;
 - Decúbito ventral.

ATITUDES INVOLUNTÁRIAS

- Atitude passiva;
- Ortótono;
- Opistótono;
- Emprostótono;
- Pleurostótono;
- Posição em gatilho;
- Torcicolo e mão pêndula da paralisia radial.

A healthcare worker wearing a yellow protective suit, glasses, and a face mask is attending to a male patient lying in a hospital bed. The patient is shirtless and has a heart rate monitor electrode on his chest. The background shows a clinical setting with medical equipment and a red biohazard symbol on a wall.

ATITUDES INVOLUNTÁRIAS

Atitude passiva – Quando o paciente fica na posição em que é colocado no leito, sem que haja contratura muscular. É observada nos pacientes inconscientes ou comatosos.

ATITUDES INVOLUNTÁRIAS

Ortótono (orthos = reto; tonus = tensão) – Atitude em que todo o tronco e os membros estão rígidos, sem se curvarem para diante, para trás ou para um dos lados.





ATITUDES INVOLUNTÁRIAS

Opistótono (opisthen = para trás; tonus = tensão) – Atitude decorrente de contratura da musculatura lombar, sendo observada nos casos de tétano e meningite. O corpo passa a se apoiar na cabeça e nos calcanhares, emborcando-se como um arco.



ATITUDES INVOLUNTÁRIAS

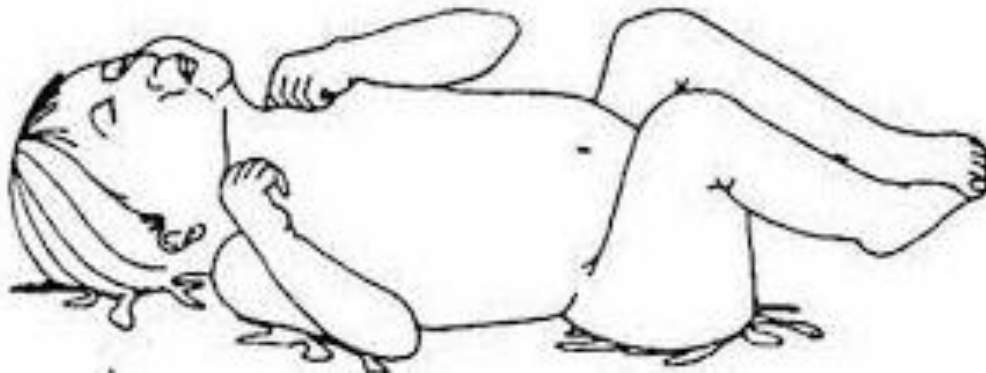
Emprostótono (emprosthen = para diante; tonus = tensão) – Observada no tétano, na meningite e na raiva, é o contrário do opistótono, ou seja, o corpo do paciente forma uma concavidade voltada para diante.



ATITUDES INVOLUNTÁRIAS

Pleurostótono (pleurothen = de lado; tonus = tensão) – Observação rara no tétano, na meningite e na raiva. O corpo se curva lateralmente.

ATITUDES INVOLUNTÁRIAS



Posição em gatilho – Encontrada na irritação meníngea, é mais comum em crianças e caracteriza-se pela hiperextensão da cabeça, flexão das pernas sobre as coxas e encurvamento do tronco com concavidade para diante.

ATITUDES INVOLUNTÁRIAS

Torcicolo e mão pêndula da paralisia radial – Atitudes involuntárias relacionadas a determinados segmentos do corpo.



BIÓTIPO OU TIPO MORFOLÓGICO

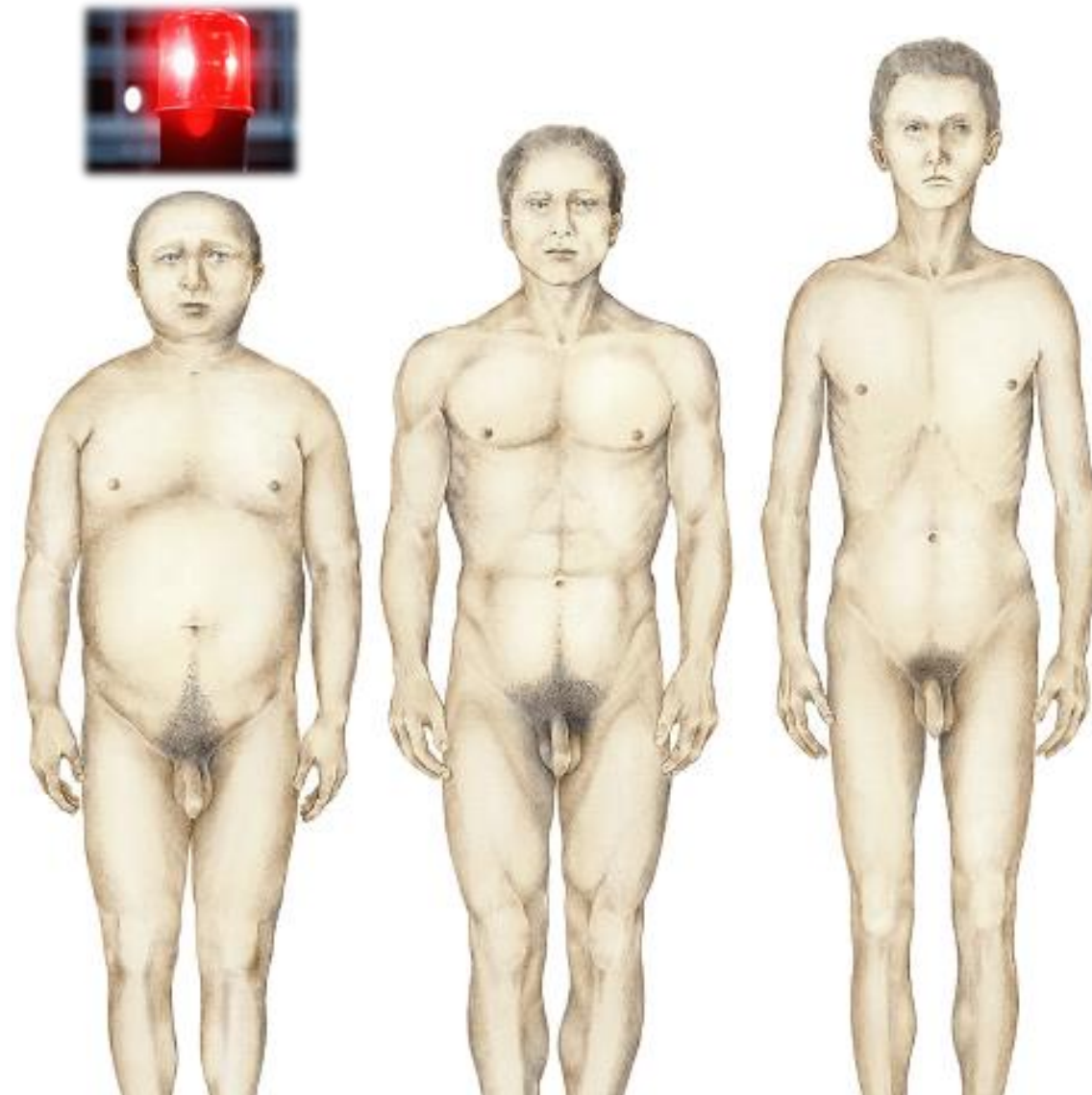
Conjunto de características morfológicas apresentadas pelo indivíduo. Não confundir biótipo com altura. Conquanto haja certa correlação entre a altura e o tipo constitucional, são conceitos diferentes.



BIÓTIPO OU TIPO MORFOLÓGICO

Brevilíneo

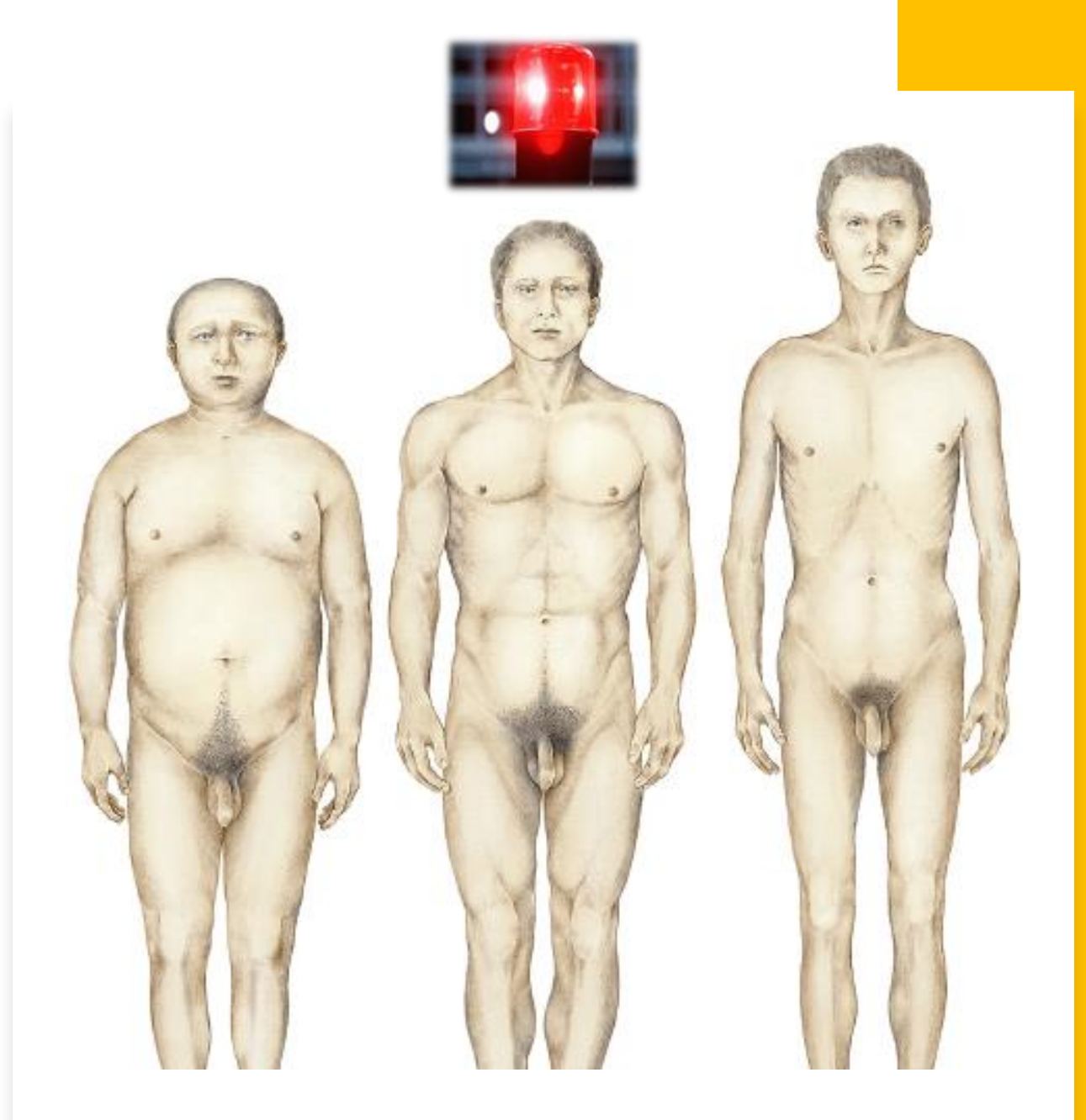
- ✓Pescoço curto e grosso;
- ✓Tórax alargado e volumoso;
- ✓Membros curtos em relação ao tronco;
- ✓Ângulo de Charpy (costal) maior que 90° ;
- ✓Musculatura desenvolvida e panículo adiposo espesso;
- ✓Tendência para baixa estatura.



BIÓTIPO OU TIPO MORFOLÓGICO

Mediolíneo

- ✓ Equilíbrio entre os membros e o tronco;
- ✓ Desenvolvimento harmônico da musculatura e do panículo adiposo;
- ✓ Ângulo de Charpy (costal) em torno de 90°.



BIÓTIPO OU TIPO MORFOLÓGICO

Longilíneo

- ✓Pescoço longo e delgado;
- ✓Tórax afilado e chato;
- ✓Membros alongados com franco predomínio sobre o tronco;
- ✓Ângulo de Charpy (costal) menor que 90° ;
- ✓Musculatura delgada e panículo adiposo pouco desenvolvido;
- ✓Tendência para estatura elevada.





**“ Todo paciente que
você vê é uma lição
muito maior do que a
doença da qual ele sofre.”**

William Osler

REFERÊNCIAS

1. Exame Clínico- Celmo Celeno Porto - 8ª Edição. 2017. Editora Guanabara Koogan. (pag: 226-286)
2. Bates - Propedêutica Médica - Lynn S. Bickley. 13ª Edição. 2022. Editora Guanabara Koogan (pag: 178-186)